

Constipación

Bibliográfica 2025 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David

“Estreñimiento funcional en pediatría, diagnóstico y tratamiento” – SAP 2021

Servicio de Gastroenterología hospital Garrahan: “Manejo terapéutico actual de la constipación en niños” - 2018

Epidemiología

En la edad pediátrica la constipación crónica constituye el 3% de la consulta clínica, y el 25% de la gastroenterología.

Sólo en un 5% de los pacientes la constipación corresponde a una causa orgánica, siendo en el 95% de los casos, de origen funcional.

Definición: criterios de Roma IV para estreñimiento funcional

Criterios diagnósticos para neonatos y niños menores de 5 años

Deben incluir, como mínimo, dos de los siguientes durante, al menos, un mes:

1. Dos o menos deposiciones por semana.
2. Historia de retención fecal excesiva.
3. Historia de defecación dolorosa o de deposiciones duras.
4. Historia de deposiciones voluminosas.
5. Presencia de una gran masa fecal en el recto.
6. En niños continentales fecales, pueden usarse los siguientes criterios adicionales:
 - Al menos, un episodio semanal de incontinencia.
 - Historia de deposiciones voluminosas que pueden obstruir el sanitario.

Criterios diagnósticos para niños de 5 a 18 años

Deben incluir dos o más de los siguientes, con ocurrencia, al menos, una vez por semana, por un mínimo de un mes, con criterios insuficientes para el diagnóstico del síndrome de intestino irritable:

1. Dos o menos deposiciones por semana en el sanitario.
2. Al menos, un episodio de incontinencia fecal por semana.
3. Historia de posturas retentivas o retención fecal excesiva voluntaria.
4. Historia de defecación dolorosa o de deposiciones duras.
5. Presencia de una gran masa fecal en el recto.
6. Historia de deposiciones voluminosas que pueden obstruir el sanitario.

Después de una evaluación médica apropiada, los síntomas no pueden atribuirse a otra afección.

Signos de alarma en la constipación infantil. “Banderas rojas”

- Constipación de inicio precoz.
- Eliminación tardía de meconio (> 48 h de vida).
- Retraso del crecimiento.
- Sin hábito retencionista.
- Presencia de síntomas digestivos altos (vómitos).
- Distensión abdominal recurrente.
- Patología vesical.
- Sin respuesta al tratamiento convencional pasados los 3 meses de este.

Frecuencia normal de deposiciones:

- Recién nacido y lactantes con LM: 2-7/día:
 - A esta edad el nº de deposiciones puede igualar a nº de tomas de leche.
 - Las deposiciones son menores en los alimentados con leche artificial.
- Lactante con alimentación complementaria: al menos 3/semana
- Niños mayores: 2/semana

Regulación evacuatoria voluntaria entre los 2 y 3 años

Fisiopatología

La constipación puede deberse a diferentes mecanismos tales como:

- Aumento de la reabsorción de agua; colon transverso.
- Alteración de la propulsión; colon izquierdo.
- Almacenamiento inapropiado colon sigmoide.
- Aumento de la actividad segmentaria.
- Anomalías de la relajación del esfínter externo (contracción voluntaria) y de la musculatura puborrectal, especialmente cuando hay presencia de dolor.
- Distensión del recto con alteración de la sensación del deseo de defecación, por modificaciones en sus propiedades elásticas.

En los niños constipados crónicos el mínimo volumen para producir el reflejo de relajación (volumen crítico) está incrementado, así también el volumen par percibir una sensación consiente de recto ocupado (volumen umbral).

Etiología

1. Funcional

- 90-95 % de los casos
- Retención intencional (Observar la aparición de posturas retentivas (bailoteo, cruce de piernas, etc.) y animar al niño a defecar en ese momento.
- Dieta baja en fibras y alta en carbohidratos complejos, ingesta de poco líquido
- Exceso de leche de vaca
- Psicógena: causa más frecuente en > de 2 años (viajes, mudanzas, separación familiar)
- Inmovilización
- Confusión del lactante
- Síndrome de colon irritable
- Estimulación precoz para controlar esfínteres. El control de los esfínteres se suele alcanzar entre los 2-3 años, con variaciones individuales. La retirada del pañal debe comenzarse cuando el niño tenga un patrón de defecación normal y muestre que ya está preparado mediante indicadores fisiológicos, conductuales y del desarrollo.

Indicadores de que el niño está preparado para el control de esfínteres

Grupo	Indicador
Fisiológicos	Control voluntario sobre el esfínter
	Mielinización de la vía piramidal
Madurativos	Capacidad de ir caminando al cuarto de baño
	Estabilidad para mantenerse sentado en el retrete
	Capacidad para mantenerse seco durante varias horas
	Capacidad para ponerse y quitarse ropa
	Capacidad de obedecer una orden verbal de 2 pasos (lenguaje receptivo)
	Capacidad de comunicar la necesidad de usar el retrete (lenguaje expresivo)
	Darse cuenta de los escapes
	Llamar la atención sobre sus pañales sucios
	Distinguir verbalmente orina de heces
	Capacidad para imitar conductas
Conductuales	Capacidad para colocar las cosas en su sitio
	Decir no para demostrar independencia
	Manifestar interés por aprender el control de esfínteres
	Deseo de agradar
	Deseo de independencia y control de las funciones de eliminación
	Disminución de la frecuencia de conductas oposicionistas y luchas de poder
	Capacidad de anunciar que va a evacuar
	Capacidad de pedir que le lleven al retrete

2. Orgánicas

a. Secundario a trastornos endocrinos o metabólicos

- Hipotiroidismo
- Acidosis renal
- Diabetes mellitus
- Celiacía
- Hipercalcemia
- Esclerodermia
- LES

b. Obstructivo

- Fisuras anales
- Localización anterior del ano
- Estenosis anal y atresia anal
- Fibrosis quística
- Tumores

c. Estreñimiento neurogénico

- Trastornos de la médula espinal (mielomeningocele, tumor, etc.)
- Parálisis cerebral, hipotonía
- Enfermedad de Hirschsprung
- Megacolon congénito
- Chagas
- ECNE
- Botulismo

3. Inducido por drogas

- Anticolinérgicos
- Bismuto
- Antihistamínicos
- Fenitoína
- Diuréticos
- Imipramina (antidepresivo tricíclico)
- Fenotiacidas
- Antiácidos (aluminio)
- Medicación con codeína
- Intoxicación con plomo

Anamnesis

Permite en un primer tiempo desglosar los diferentes componentes patogénicos más frecuentemente implicados y diferenciar el estreñimiento ocasional en el preescolar (fisura, cambio de régimen de vida, problemas familiares, hospitalización, etc.) del estreñimiento crónico.

- Eliminación de meconio
- Antecedentes familiares de Hirschsprung
- Antecedentes quirúrgicos
- Control de esfínteres
- Edad de comienzo (de comienzo muy precoz debe hacer pensar en una causa orgánica)
- Hábito evacuatorio
- Aspecto de las heces (con heces acintadas pensar en una estenosis del canal anal)
- Presencia o no de sangre
- Pérdida fecal involuntaria: encopresis (escurrimiento de ropa interior)
- Existencia de abombamiento abdominal, dolor abdominal o astenia
- Vómitos, alternancia de vómitos y diarrea

- Existencia de trastornos miccionales (enuresis, infección urinaria, disuria).
- Régimen de vida, el modo de alimentación (harinas, espesantes, fibras) y apetito
- Tratamientos prescritos y la automedicación (antitusígenos, derivados opiáceos, atropínicos)
- Problemas familiares
- Fisura
- Antecedentes de reposo prolongado
- Desarrollo pondoestatural
- Hospitalizaciones

Evaluación del tacto rectal

- Tono del esfínter (conservado, hiper o hipotónico)
- Ampolla rectal llena o vacía
- Consistencia de la materia fecal (blanda, dura elástica)
- Dedo de guante (limpio o sucio)

Diagnóstico diferencial con enfermedad de Hirschsprung

En pacientes con constipación crónica severa, refractaria al tratamiento, sospechar enfermedad de Hirschsprung o megacolon congénito. La presencia de un de diarrea después de un tacto rectal, dejando la ampolla rectal vacía también nos hará sospechar esta patología

	Estreñimiento funcional	Enf. de Hirschsprung
<i>Inicio al nacimiento</i>	Raro	Frecuente
<i>Enterocolitis</i>	No	Posible
<i>Encopresis</i>	Frecuente (4 años)	Rara
<i>Tamaño de las heces</i>	Grandes	Acintadas o normales
<i>Retraso ponderal</i>	Raro	Frecuente
<i>Ampolla rectal</i>	Llena	Vacía
<i>Tono del esfínter</i>	Variable	Elevado

Exámenes complementarios

Sedimento de orina: en estos pacientes hay predisposición para ITU, en particular en las niñas.

Analítica: no es trascendental, en nuestro hospital se solicita analítica general cuando el paciente se interna.

En algunos casos especiales, de inicio agudo, se podría tener en cuenta la posibilidad de:

- Hipotiroidismo
- Enfermedad celíaca
- Hipercalcemia en pacientes con constipación funcional.

Radiografía abdominal

- Incidencia de frente con el paciente de pie.
- No es necesaria, se solicita en casos de duda o distensión abdominal importante.
- Puede ser útil para valorar una retención fecal y la existencia o no de alteraciones de la columna lumbosacra, o en aquellos niños que, o bien por ser muy obesos o por negativa, es imposible hacer una buena exploración abdominal y tacto rectal.
- También se utiliza cuando la distensión abdominal es importante.

En constipación severa con sospecha de alteración orgánica:

- Para descartar la aganglioneurosis: biopsia rectal
- Manometría para evaluar relajación esfinteriana

Criterios de internación

- Deterioro del estado general
- Suboclusión intestinal o íleo
- Dificultad en el diagnóstico o tratamiento ambulatorio

Tratamiento

Constipación ocasional

- Dietético
- Tratamiento del factor desencadenante (fisura, etc.)
- Osmóticos o lubricantes

Constipación crónica

Manejo integral

1. Desimpactación fecal cuando es necesario
2. Mantenimiento (prevención de la reacumulación de deposiciones)
3. Seguimiento periódico (durante el tratamiento y una vez suspendido)

Desimpactación

1º: Desimpactación manual: intentando romper la masa fecal al realizar el tacto.

A. Vía oral

○ **Polietilenglicol**

Laxante iso-osmótico no absorbible, de alto peso molecular, que no se metaboliza y actúa por oposición a la absorción de agua en el intestino.

Vía oral en dosis bajas de 1 a 1,5 g/kg/día (1 sobre de "Barex unipeg" c/10 Kg, máximo 6 sobres) durante; 3 a 7 días. La dilución es de 1 sobre en 1 vaso de agua. Es preferible que dichas tomas estén separadas por un corto espacio de tiempo, no más de 6-8 horas entre ambas dosis. Con esta pauta, se logra la desimpactación en los primeros 3-4 días en el 90% de los niños.

○ **Aceite mineral: Vaselina** (no en < de 1 año)

- Agente no irritante que lubrica el intestino, inhibe la absorción colónica de agua aumentando el contenido de agua de la materia fecal y promoviendo su pasaje.
- Dosis es de 15 a 30 ml/por año de edad, máximo 240 ml/día.
- Nunca administrar a la fuerza ya que puede broncoaspirarse.

B. Vía rectal: enemas

- Es efectiva y rápida pero invasiva, afecta emocionalmente al niño y a veces hay dificultades familiares para su aceptación y/o administración.
- Actualmente se reserva para constipación orgánica o fracaso con el PEG.
- A través de una sonda Nelaton de 14-16 introducida entre 10 y 20 cm más allá del margen del ano, según el tamaño del niño.
- **Con fecaloma:** Tacto rectal con presencia de materia fecal de consistencia dura.
 - **Enema de Murphy** continuo a 7 gotas/minuto (disuelve)
Preparación: 10ml de bicarbonato, 5ml de cloruro de sodio y 500 ml de SF
- **Sin fecaloma o luego de la desimpactación de este** (detectado por la presencia de defecación más la repetición del tacto rectal)
 - **Enema evacuante** en infusión lenta c/12 hs:
 - ✓ Preparación: 1/3 vaselina y 2/3 de solución fisiológica
 - ✓ Volumen total de 5 ml/kg con un máximo de 500 ml
 - ✓ Frecuencia: hasta 4 veces por día y en general por hasta 5 a 7 días (por mayor tiempo puede producir alteraciones electrolíticas).

- ✓ Pueden utilizarse enemas de fosfato a 30 ml cada 5 kg de peso hasta un máximo de 135 ml, pero no es aconsejable su uso reiterado o prolongado, ya que puede producir hipernatremia, hiperfosforemia, hipocalcemia e hipokalemia.

En esta etapa es importante no aumentar la fibra de la dieta para no incrementar el volumen de las deposiciones. Mantener una dieta variada, no astringente y con pocos lácteos.

Enemas de fosfatos hipertónicos

Dosis de 3-5 ml/kg/12 horas.

En muchos niños, 1 ó 2 enemas suelen ser suficientes para alcanzar una buena limpieza, aunque a veces son necesarios de 3 a 5 días. Está contraindicado efectuarlo más de 5 días, por la posibilidad de provocar trastornos hidroelectrolíticos (hipernatremia, hipocaliemia, hipocalcemia e hiperfosfatemia). En aquellos niños con megarrecto o megacolon que no responden a los enemas de fosfatos, podrán utilizarse enemas de aceite mineral. Los enemas de suero salino isotónico no son efectivos.

Dosis y efectos secundarios de los laxantes más usados		
Laxante	Dosis	Efectos secundarios
Lactulosa	1-3 ml/kg 1-2 veces/día	Flatulencia, abdominalgia
PEG mantenimiento	0,26-0,84 g/Kg/día	Diarrea, mal sabor
PEG desimpactación	1-1,5 g/Kg/día (3-4 días)	
Aceite mineral	Mantenimiento :1-3 ml/kg/día Desimpactación: 30 ml/10 kg ó 15-30 ml/año edad/día	Mal sabor, pérdida anal, neumonía aspirativa
Enema fosfatos	3-5 ml/kg/12-24 horas	Hiperfosfatemia

Mantenimiento (prevención de recaída)

Medicación: La elección del medicamento no es tan importante como encontrar la dosis adecuada que permita mantener evacuaciones blandas, todos los días o día por medio. Debe evitarse la reimpactación hasta encontrar la dosis y el tipo de laxante adecuado, indicando enemas si pasan más de 3 días sin evacuación.

Se utilizan más frecuentemente:

- 1) **Lubricantes:** como el aceite mineral en dosis de 1 a 5-ml/kg/día en 1 a 2 dosis diarias. Su efectividad ha sido bien demostrada. Está contraindicado su uso en mejores de 1 año, vomitadores, y niños con daño neurológico por el riesgo de aspiración.

2) Osmóticos:

▪ Lache de Magnesia

- ✓ Dosis de 1 a 3 ml/kg/día.
- ✓ Puede producir como efecto adverso hipermagnesemia, hipofosforemia e hipocalcemia.

▪ Lactulón® (lactulosa)

- ✓ Tiene una doble acción: no se absorbe en el intestino delgado, y llega al colon donde se metaboliza por acción de las bacterias a metabolitos ácidos. El pH ácido estimula el peristaltismo, y disminuye el tiempo de tránsito, por lo que disminuye la absorción de agua. Secundariamente, la lactulosa es osmóticamente activa, atrayendo líquido a la luz intestinal y estimulando el peristaltismo.
- ✓ Dosis: 1 ml/kg/día (máximo 30 ml).
- ✓ Puede producir flatulencia y dolor abdominal.

▪ Polietilenglicol

- ✓ Dosis: 0,4 a 0,6 gr/kg/día

Alimentos ricos en fibras y/o la suplementación con productos comerciales con fibra, una vez resuelta la encopresis y la retención fecal.

En menores de 6 meses, (una vez descartada la etiología orgánica por anamnesis y examen físico), es poco probable que el síntoma requiera tratamiento. Hay que informar a los padres sobre el carácter benigno del fenómeno y que no es necesaria en general ninguna intervención y que conviene abstenerse de la estimulación rectal. Estimular la lactancia y descartar la hipoalimentación.

En el lactantes > 6 meses, estimular la ingesta de líquidos/jugos desfrutas frescas (ciruelas, kiwi, naranja, etc.). La recomendación de la Academia Americana de Pediatría es la ingesta de 0,5g/kg/día de fibra hasta un máximo de 35 gr (una rebanada de pan integral, 3 cucharadas soperas de cereales o 1/2 taza de verdura tipo espinaca, brócoli, zanahoria, maíz contienen entre 2 y 4 gr de fibra).

Con la introducción de comidas sólidas en la dieta del niño deben incluirse cereales integrales, frutas y vegetales sin excluir otros alimentos, ya que la densidad calórica de los alimentos ricos en, fibras es baja.

3) Reentrenamiento de hábitos evacuatorios

El tratamiento de la constipación requiere de paciencia y la conformación de un equipo con el niño y la familia.

En la etapa del control de esfínteres debe evitarse que los glúteos queden atrapados en la bacinilla o que el niño tenga sensación de caerse dentro del inodoro. Debe tener punto de apoyo para los pies para favorecer la prensa abdominal.

Debe invitársele al baño cuando hay claras manifestaciones de deseo de defecar, o después de haber comido.

No hay que avergonzarlo, atemorizarlo ni castigarlo, ni extremar los hábitos obsesivos de higiene.

Con los niños mayores hay que consensuar el reentrenamiento del hábito de defecar dedicando tiempo de concurrir al baño después de las comidas 2 veces por día (10 a 15 minutos), y evitar las conductas retentivas en respuesta a la urgencia de defecar.

Las recaídas (reimpactación, escurrimiento) son frecuentes y obligan a revisar el tratamiento y el cumplimiento de las pautas de reeducación.

El fallo reiterado con adecuada adherencia obliga a revisar el diagnóstico.

Seguimiento

La etapa de reeducación y mantenimiento dura meses.

Una vez que el niño logra el objetivo de una evacuación diaria de consistencia normal se puede disminuir la dosis de laxantes en forma gradual, incrementando paulatinamente la fibra de la dieta.

Al término de 6 a 12 meses se puede discontinuar el tratamiento con laxantes con la precaución de mantener al paciente en control y reiniciando el tratamiento farmacológico si la constipación recurre.

Estreñimiento o constipación Anexos para padres

Alimentos ricos en fibras:

- Todas la ensaladas crudas
- Garbanzos, lentejas, habas, porotos, milanesas de soja
- Arroz integral
- Avena, salvado (también utilizar para la preparación de milanesas)
- Espinaca, acelga
- Choclo
- Puerro
- Zanahoria, zapallo
- Tomate
- Cebolla
- Galletas de salvado o integral
- Pan integral
- Ciruela, moras, frambuesas, frutillas, peras, durazno, damasco, kiwi, uva, sandia
- Cítricos (naranja , mandarina, pomelo, limón, si es en jugo: con pulpa)
- Frutas secas (pasas)
- Almendras, nueces
- Barras de cereal

Reentrenamiento de hábitos evacuatorios

El tratamiento de la constipación requiere de paciencia y la conformación de un equipo con el niño y la familia.

En la etapa del control de esfínteres debe evitarse que los glúteos queden atrapados en la pélela o que el niño tenga sensación de caerse dentro del inodoro. Debe tener punto de apoyo para los pies para favorecer la prensa abdominal (nunca dejar que cuelguen).

No hay que avergonzarlo, atemorizarlo ni castigarlo, ni extremar los hábitos obsesivos de higiene.

Con los niños mayores hay que consensuar el reentrenamiento del hábito de defecar dedicando tiempo de concurrir al baño después de las comidas 2 veces por día (10 a 15 minutos), y evitar las conductas retentivas en respuesta a la urgencia de defecar.

Seguimiento: Tener paciencia, la etapa de reeducación y mantenimiento dura meses.

Una vez que el niño logra el objetivo de una evacuación diaria de consistencia normal se puede disminuir la dosis de laxantes en forma gradual, incrementando paulatinamente la fibra de la dieta.

Al término de 6 a 12 meses se puede discontinuar el tratamiento con laxantes con la precaución de mantener al paciente en control y reiniciando el tratamiento farmacológico si la constipación recurre.